

05 - 5 rate sono maker

Le deuxième cours est concernant l'ARAS. Pour fixer certains objectifs, on est dans la circulation de l'ARAS, sa configuration externe et interne et ses moyens de l'exciter, ses rapports prépondérés vers l'eau, la vascularisation matérielle des eaux et son énévation. On se fera enregistrer dans le temps suivant.

Et comme définition, l'ARAS, il est appelé également, et selon les ordres saxons, l'hypertrocare composé de deux tissus, un tissu vivant pourri qui assure la fonction immunitaire et un tissu réticulaire qui participe à la régulation des éléments figurés du sang, c'est-à-dire la fabrication et la destruction de ces éléments. S'adresse, il est appelé également, la cimetière des gourilles rouges et des plaquettes. Parce que la destruction de ces éléments des sangs, elles vont être dyshéroïques au niveau de l'ARAS.

Pour cela, il est qualifié pour des cimetières des gourilles rouges et des plaquettes. Cette ARAS, elle est enveloppée d'une capsule, elle enferme des fibres musculaires. Ces fibres musculaires lissent.

Lorsqu'elles se contractent, elles vont permettre la régulation de la masse sanguine circulante. Ce phénomène-là est appelé la sphéno-contraction. C'est un organe qui est réparti.

La rupture de cet organe va donner ce qu'on appelle un sévèrement, un choc hémorragique qui peut être mortel. Sur ce schéma-là, on a un organe qui est fracturé en plus. Ce n'est pas seulement une hémorragie.

Pour faire l'hémostase dans cette situation-là, on va opérer le patient. Il faut faire une ablation de sa part. Vous voyez ici l'ARAS qui est fracturé.

On n'arrive jamais à faire sans hémostase. Il faut faire son ablation après la sphéno-contraction. Vous avez étudié la terminologie ? L'ablation de l'ARAS, c'est la sphéno-contraction.

Vous voyez que l'ARAS n'est pas indispensable à la vie, mais sans l'ablation, elle va engendrer un risque actuel d'infection et de thrombose. C'est pour cela que chez les patients sphéno-électromisés, c'est-à-dire chez qui on a mangé l'ARAS, on doit administrer une vaccination. Il doit suivre un tableau vaccinal, c'est-à-dire une vaccination anormale, et d'autres types de vaccins.

Cette ARAS, elle se situe dans les bases sus-misoporiques, c'est-à-dire par rapport aux mises à vol en France. Elle se trouve dans les bases sus-misoporiques. Elle va occuper les poumons de la gauche, après également la loge supérieure de gauche, sous la poitrine diagnostique gauche, et elle est en position dans la boucle abdominale.

Donc c'est un organe par rapport à l'abdominal. Parfois, au niveau du CRM, ils vont vous demander la situation, soit à la base sus-misoporique, soit les poumons de gauche, la loge

supérieure de gauche, pour que l'ARAS est un organe par rapport à l'abdominal. Donc ça traite qu'il va occuper une loge clinique qui est limitée en Europe par le diagramme, en avant, elle va être balayée par l'estomac, et essentiellement par le fundus, c'est la loge supérieure de gauche, en arrière, par l'extrémité supérieure de l'ARAS ou de la supranargauche, et en bas, par l'ongle colicoche et le ligament clinico-colique.

Donc si on vous dit les limites de la loge clinique, en haut, il y a le diagramme, en avant, elle va être balayée par l'estomac, essentiellement par le fundus, en bas, il y a l'ongle colicoche et le ligament clinico-colique, et en arrière, il y a le pôle supérieur ou l'extrémité supérieure de l'ARAS ou de la supranargauche. Est-ce qu'on peut avancer ? Non, ce n'est pas le fundus. Le fundus, ce n'est pas la grosse divosité.

La grosse divosité, c'est à part. Ça, c'est le fundus. Par exemple, il y a le fundus.

En haut, c'est l'approche à la gastrée. La grosse divosité, c'est ici. Et ça, c'est ça.

Le fundus, ici, c'est l'envers. Donc, sur ce diagramme, si tu le vois, c'est humain. C'est un patient qu'on a réalisé, chez qui on a réalisé une spénichromie, parce qu'il présente une maladie hématologique.

C'est le pulvérat thrombopénique. Pas pour l'humain. C'est un problème de thrombopénique.

On a réalisé une spénichromie. Vous voyez, c'est un organe qui ouvre et se forme d'une caramie à base intérieure et à sommet supérieur. Il a un corps plus ou moins triangulaire.

C'est un organe qui ouvre et qui se forme d'une caramie à base intérieure et a un grand axe qui est parallèle à la deuxième corde gauche. Cet organe, il ferme, mais il reste toujours veillable, c'est-à-dire fragile. et qui ferme.

C'est simplement les parties séparables qui s'accumulent lors d'un traumatisme et proviennent d'une hémorragie, comme on l'a déjà dit, dans la dernière diapositive. Cet organe a une couleur rouge, dit de vin. Chez tous les gens, on ne peut pas parler d'un organe.

La rate est sous le rebord costal gauche et n'est pas palpable sur les sujets qui sont en haut. Lorsqu'il va augmenter de volume et en plus de son association à l'esprit mécanique, on arrive à la palpée. C'est-à-dire une mécanique qui se voit dans certaines pathologies telles que l'hypertension cortale, certaines maladies parasitaires et des maladies climatologiques telles que l'hémophilie et l'hallucine.

Une question thoracique compose des concours soit d'internat, de l'ISIS-ANOR, des professeurs assistants. C'est le traumatisme basé thoracique gauche. Basé thoracique, il y a le traumatisme du contenant et du contenu.

La cage thoracique, les côtes, la base primonaire et la plaire, le cœur et des côtés de la

pommelle, il y a la rade, il y a le colon, les ongles poulis gauche. Donc lors du traumatisme basé thoracique gauche, on peut assister à une rupture de rade. La rade est cachée derrière un décor.

Sauf si on a un bout de contrôle. Par exemple, au lieu d'avoir une main, un contrôle ici, une flèche pénétrante qui peut arriver jusqu'au niveau de la rade. Généralement, la rade, elle va se rendre en dehors d'un traumatisme basé thoracique gauche ou un traumatisme qui est latéral.

Au principe, elle est protégée par les dernières côtes. Donc, lorsqu'on a une sphénomégalie, la rade, elle va dépasser son repos postal. Là, elle va être parfaite.

On se sert sur ce schéma-là, sur cette photo, on demande aux patients de faire une inspiration profonde et on va suivre. On va mettre un bout d'arnaque sur le repos postal. On va essayer de déprimer cette région-là pour essayer de parfaite la rade.

Lors de l'examen de la rade, on va demander aux patients de faire une inspiration profonde. S'il vous plaît. Donc, cette rade-là, elle va mesurer au moyen 13 pour 8 fois 3 centimètres.

Et elle va avoir un poids moyen de 150 à 200 grammes. Cette rade-là, elle va présenter trois faces. Une face qui est externe, c'est cette face-là.

Donc, cette face-là évite le piaf pragmatique, parce que elle repose sur le piaf pragmatique. La deuxième face, c'est une face qui est interne. Donc, elle est appelée face viscérale parce qu'elle repose sur les viscères.

Cette face-là, elle est divisée en deux faces. Une face enterre-interne, c'est une face disgastrique. Une face posterre-interne évite le piaf pragmatique.

Est-ce que vous arrivez à suivre? Non. Donc, la rade présente trois faces. La face des piafs pragmatiques, c'est-à-dire la face qui est en contact avec le piaf pragmatique.

Deuxième face viscérale, il y en a une, qui rentre en contact avec les viscères qui sont à côté. Donc, le côté antérieur, appelée la face antérieure-interne, c'est la face gastrique. Vous voyez cette aspect-là? C'est le bord créneux.

C'est un bord antérieur. Le bord, un bord créneux. Et là, cette aspect-là.

Donc, comme il y a des empreintes, il y a des côtes sur ce bord-là. D'abord, le bord compact, lors de l'examen, n'est pas ça. Donc, c'est un bord antérieur.

C'est un bord créneux. D'accord? Ce bord postérieur, vous voyez qu'il est réduit. Donc, le bord antérieur, il est créneux.

Donc, ici, c'est la face antérieure-interne. Et cette face-là, c'est celle qui repose, qui est en contact avec l'estomac. La face postérieure, vous voyez ici l'empreinte, c'est le port supérieur.

Ici, c'est le port supérieur. On va rappeler le port supérieur. Donc, c'est la face rénale-postéro-interne.

Donc, cette face-là, elle présente trois bords. D'abord, un sommet, qui est le port supérieur. Une base, le port inférieur, ou la face auric.

Et deux bords. Le bord antérieur, il est dit créneux. Vous le voyez ici.

Et un bord postérieur. Donc, on a dit la face postéro-interne, c'est la face rénale. Donc, ce bord-là, il va séparer la face diaphragmatique de la face postéro-interne, qui est la face rénale.

Un bord postérieur, vous le voyez ici, on va séparer la face postéro-interne, la face rénale, de la face diaphragmatique. Et le bord antérieur, dit créneux, il va séparer la face diaphragmatique de la face antéro-interne, la face gastrique. Et il y a également un bord météor.

Ce bord-là, il passe par l'île de l'art. Vous voyez ici, il y a un fil. Donc, on a dit qu'il y a l'artère et l'artère splénique.

D'accord? Donc, on parle véritablement de l'artère splénique, c'est-à-dire l'artère polaire supérieure et intérieure. Ici, vous voyez l'artère polaire intérieure, et l'artère polaire supérieure, splénique. Donc, le bord-médias, on regarde l'île, et ce bord-médias, il va séparer deux faces, la face gastrique antéro-interne et la face rénale postéro-interne.

Donc, jusqu'à ce bout-là, est-ce que vous avez des questions? Concernant la configuration interne, c'est juste pour vous la rappeler. Donc, c'est... Généralement, on pose partout cette partie dans les épaules. Mais pour mieux la connaître, ce qui va définir le but, puisqu'il est blanc et rouge, donc, on a dit que on trouvait une capsule qui est fibreuse et reste fragile, et qu'il faudra mettre une fibreuse sur laquelle il va se fixer ce qu'on appelle les ravitudes.

D'accord? Cette capsule-là va donner des clavés appelés ravitudes, et ces ravitudes, elles vont délimiter ce qu'on appelle les orbules et les segments. Donc, la capsule et les ravitudes sont renforcées par une fibre musculaire lisse, et lorsqu'elles vont se contracter, elles vont donner ce qu'on appelle le phénomène de fustéloncontraction qui participe à l'inculation de la masse sanguine. Entre ces ravitudes-là, on trouve les follicules lymphatiques qui sont disposées autour des artères culter et qui vont former ce qu'on appelle la culte blanche, qui est le tissu lymphoïde de la masse.

Il y a également les sinus des nœuds, vous voyez ici, ça c'est les sinus des nœuds, et qui vont former ce qu'on appelle la culte rouge, ou le tissu vestibulaire de la masse. En face. Parce que vous avez décidé de la matière disposée après, donc ici, elle est pour vous rappeler la structure interne de la masse.

Oui? Des questions? Non? Pour moi? Non? Donc là-bas, elle est maintenue fixe dans ce qu'on

appelle sa loge sphénique, dans un sac périphéral, vous voyez ici. Ce sac périphéral va donner des prolongements avec deux lames pour desserrer. La première, c'est le ligament gastro-sphénique, et le deuxième, le ligament concrético- sphénique, qu'on appelle le concrétat, ou le libre, de l'âge.

Donc le poche supérieur, donc avec les deux ligaments, c'est-à-dire le ligament gastro-sphénique, qu'on appelle le libre de l'âge, et le ligament concrético- sphénique, qu'on appelle le concrétat de l'âge, qui forme la partie gauche de la bourse fondamentale, ou de la réactivité des équilibres. Son poche supérieure, elle va être fixée au diaphragme par le ligament rhénico-sphénique. Et sa base, elle va reposer sur le ligament rhénico-coulique.

Donc, on a quatre ligaments qui fixent cette patte-là. Il y a le ligament gastro-sphénique, la trompante est formée à l'invisible de l'âge. Le ligament concrético- sphénique, on l'a marqué du concrétat qui désigne la rate.

Par contre, à l'ensemble, il est fixé sur le diaphragme par le ligament rhénico-sphénique, et la base repose sur l'angle coulique de gauche, et sur le ligament rhénico-coulique. Les questions, s'il vous plaît. Non.

Donc, la vascularisation apériure de la rate est assurée par la artère sphénique, qui est une branche de ton céliac. Le ton céliac est donc d'avoir une branche l'artère lymphatique, l'artère sphénique, et l'artère gastrique gauche. On décrit à cette artère sphénique trois portions, trois segments.

Le premier segment qui se trouve au niveau supérieur du pancréas, au niveau de la région toujours céréale. La deuxième portion de l'artère sphénique, elle est portilleuse, fixilleuse, et se situe dans une gouttière plus ou moins profonde, sur la face postérieure du pancréas. Donc sur le schéma, on en voit sur la voie supérieure du pancréas, le premier segment qui se trouve en surface pancréatique, et le deuxième segment qui se trouve dans une gouttière sur la face postérieure du pancréas.

Donc c'est un segment dit rétro-pancréatique. Et le dernier segment, c'est un segment qui est pré-pancréatique. L'artère sphénique va rejoindre une autre voie, la voie supérieure de la face du pancréas.

Donc cette troisième portion, elle se situe dans le ligament frénico-sphénique. Non. C'est le ligament pancréatico-sphénique.

La troisième partie de l'artère sphénique, elle se trouve dans le ligament pancréatico-sphénique. Je vais l'apologiser, ce n'est pas frénico, c'est pancréatico, et non pancréatico-sphénique. Donc, cet artère sphénique, il va se terminer dans la capsule de la batte.

Elle va donner les artères radiculaires, qui vont donner à leur tour les artères culturelles, et

ensuite les artères fénicides. Donc, les aliments, c'est la peau rouge. Donc, les rameaux, généralement, ils sont indépendants.

Donc, ce rameau-là, il est indépendant du deuxième. On va assister à ce qu'on va faire. On va faire une vascularisation indépendante, terminale, de l'artère.

Donc, sur cette photo-là, on peut la voir. On a ligaturé les artères poléaires supérieures de l'artère. Vous voyez cet aspect-là.

Donc, ça, c'est le bord crénelé antérieur de l'artère. La partie supérieure, elle est violacée, elle est dévascularisée, parce qu'on a déjà appliqué la vascularisation. Donc, on a sectionné l'artère polaire supérieure.

Vous voyez ici, l'artère polaire intérieure n'est pas sectionnée, n'est pas ligaturée. Donc, on a une coloration qui est normale de l'artère. Donc, cette propriété, elle permet de faire ce qu'on appelle les sphénétomées partielles.

Donc, on peut couper la partie supérieure et conserver la partie intérieure. Mais, c'est très difficile, parce que la race, c'est un organe très hémorragique, et c'est très difficile de faire l'hémostase de cette limite, de la tranche de section. Cette image opératoire, il illustre bien la vascularisation terminale indépendante de la race.

Donc, on a lié l'artère polaire supérieure, vous voyez la différence de coloration. Cette partie est dévascularisée de la race, et cette partie est très bien vascularisée, et elle a cette couleur rouge. Donc, cet artère sphénique va donner des branches collatérales.

Donc, il va donner initialement des rameaux gambriolaires de temps céniaque, au niveau de la région céniaque. Il va donner des rameaux ou des artères à destinée concrétive, à destinée gastrique, et deux artères polaires supérieures. Les branches collatérales d'artère sphénique sont en nombre de quatre.

Il y a des rameaux gambriolaires au niveau de la région céniaque, des rameaux à destinée concrétive, des rameaux à destinée gastrique, et deux artères polaires, une supérieure et l'autre inférieure. On a quatre branches collatérales, des rameaux gambriolaires de la région céniaque, des artères à destinée concrétive qui sont présentées par l'artère concrétive dorsale, et des rameaux descendants. Ici, ces petits vaisseaux-là, ce sont des rameaux descendants qui vont pénétrer dans deux branches concrétives.

Les artères à destinée concrétive sont présentées par l'artère concrétive dorsale et ces rameaux-là, concrétive descendant. Le deuxième groupe des artères à destinée gastrique sont présentés par l'artère oso-gastro-pédagogique postérieure, les artères gastrique cour, et l'artère gastro-hormonale gauche. Et enfin, accessoirement, il y a les artères polaires, sphynique, supérieure et inférieure.

Donc, quatre branches, là, quatre groupes de branches collatérales de l'artère sphynique. Le retour veineux sera assuré par la veine sphynique. Cette veine sphynique, elle va naître de la réunion du 6 à 7 grosses veines qui vont émerger de l'huile de la ratte.

Cette veine sphynique est située en arrière de la veine sphynique. Cette veine sphynique, elle va rejoindre ou la rassurer avec la veine des empéricains intérieurs pour former le temps stelomysoraïque. À son tour, ce temps stelomysoraïque, elle va s'unir avec la veine mesopérique supérieure pour former le temps fort ou la veine forte.

Donc, la veine sphynique, elle va naître d'une réunion du 6 à 7 de grosses veines qui émergent de l'huile sphynique. Cette veine sphynique, elle est derrière, en arrière de la veine sphynique. La veine sphynique, elle va rejoindre la veine mesopérique supérieure pour former le temps stelomysoraïque qui va s'unir avec la veine mesopérique supérieure pour former le temps fort ou la veine forte.

Donc, ce schéma-là, elle pratique la comique, celle d'un cardinal, celle d'un président. Vous pouvez bien le mémoriser du moment. Donc, concernant les lymphatiques, donc, il y a des lymphatiques superficielles et des lymphatiques profondes sur la pudeur.

Et bon, ça va commencer à rejoindre les lèvres veineuses de l'huile sphynique pour devenir saphigyte de la veine sphynique. Donc, l'élévation est propriée avec l'oxygène solaire qui constitue l'oxygène sphynique qui va accompagner l'échange artériel. Arrivons au rapport.

Donc, la ratte, elle présente des rapports territoriaux et des rapports avec les organes de voisinage. Donc, le périodoine viscéral, donc, il ne va pas pisser la ratte, il va se réduire pour donner ce qu'on appelle des ligaments qui vont l'obéir aux organes de voisinage. Il y a les ligaments gastro-sphyniques que voulait la ratte à la Grande Bourgogne gastrique.

Il y a également les ligaments pancréasico-sphyniques et les trinitico-sphyniques qui vont tenir la ratte au diaphragme et à la paroi de voisinage extérieur. Donc, au niveau des îles, ce ligament-là, il va contenir la queue du pancréas. Il peut être accolé de façon plus ou moins intolérante.

Donc, lors de l'ablation de la ratte, parfois, on est obligé de faire une dissection de la queue du pancréas. Donc, pour les rapports avec les organes de voisinage, on va prendre cette ratte qui représente une face diatragmatique, une face viscérale, une face gastrique, une face pénale, un port supérieur et une face dite face coulée. Maintenant, pour la face diatragmatique, donc la projection parétale de la ratte en avant et se fait en regard de la ligne axillaire.

Donc, ici, j'ai pas trouvé, il y en a des repas de chemin qui vont illustrer l'ensemble des rapports. En arrière, il y a une ligne latérale à 5 cm du processus des nœuds vertébraux dans le 10e espace intercostal. En haut, la courbure, il y a une courbure qui convexe envers l'avant et remonte jusqu'au 8e espace intercostal.

En bas, il y a une courbure qui convexe envers l'arrière et qui va descendre du pouvoir inférieur de la 2e coque. Donc, les rapports de cette face diaphragmatique, en avant avec la ligne axillaire moyenne, en arrière avec une ligne qui passe à 5 cm du processus des nœuds vertébraux dans le 10e espace. En haut, c'est-à-dire le pôle supérieur pour le sommet de la rate.

Donc, il y a une courbure qui convexe envers l'avant et qui va remonter jusqu'au 8e espace intercostal. Et en bas, c'est-à-dire la base de la rate. Un rapport avec une courbure qui convexe en bas et en arrière et qui va descendre jusqu'au pouvoir intérieur de la 11e coque.

Ça, c'est ce que conserve la face diaphragmatique. Pour la face viscérale, elle va comporter trois surfaces. Une surface qui est reine.

Donc, la concavité de la rate, elle va mouler la convexité de l'extrémité supérieure du terrain gauche et de la surmenance gauche. Il y a également une surface gastrique. La concavité de la rate, elle va répondre à la convexité de l'estomac.

La base postère de l'estomac. Et cette face-là, elle va répondre également à la queue du pancréas qui vient au contact limite de la rate. Donc, j'ai dit que ceci explique parfois qu'on est obligé de sectionner une partie de la queue du pancréas lors de la réalisation d'une sphérique.

Il y a une face coulique. Elle est grossièrement plane. Elle repose sur l'angle coulique gauche et sur également l'angle coulique gauche.

Pour l'extrémité postérieure supérieure, ça répond à l'induce. Pour les bords, il y a le bord antérieur et le bord postérieur. Le bord antérieur qui est très laid, qui sépare cette face viscérale de la face gastrique par rapport à la face diaphragmatique.

Donc ce bord supérieur-antérieur, il va s'insuliner entre le diaphragme et l'estomac. Et les incisures caractéristiques permettent de reconnaître lors d'une sphérique négative qui est parfaite. On a déjà vu cette situation.

Lorsqu'on a des bords couliques, on dit qu'ils vont rire. Et même pas sur le bord postère, on va parler de ce bord antérieur qui est très laid. Il est très laid.

Il y a cette structure-là. C'est une petite dépression. C'est son caractéristique de l'arache lorsqu'il se rend pas.

Et dans le bord antérieur, ce bord, il mousse. Il mousse et il va s'insuliner entre le diaphragme et le port supérieur de l'angoisse. Ici, cette structure-là, c'est la sirena.

Vous la voyez ici. Les collants couverts qu'ils ont chez moi, c'est la sirena d'angoisse. Ça, c'est le port supérieur de l'angoisse.

L'estomac, c'est ce port. Il mousse. Il mousse par le bord postérieur et par le bord antérieur.

Donc, c'est la sirena. Vous voyez, il n'est pas dans un seul plan. Par rapport à l'arache.

Donc, l'estomac est antérieur par rapport à l'arache. Le port postérieur du supérieur. Oui.

L'extrémité supérieure. Il est le port postérieur. L'extrémité supérieure, c'est-à-dire le sommet de l'arache.

Il va répondre à la base postérieure du pelvis. C'est le sommet de l'arache qui va répondre au pelvis.